

BioMaster 候选精简专家可行性复核

这版按“GPT 高强度人工复核”的方式重读五个疾病方向各 Top10 候选：不再把分数当结论，而是逐项判断这个组合是什么意思、是否像新发现、第一步怎么验证、为什么可能不值得做。结论仍然是计算优先级和专家审阅建议，不是生物学验证结果。

50 候选	5 疾病方向	2 优先讨论	9 暂缓/不首轮
----------	-----------	-----------	-------------

核心口径。先看这个候选能否被一个直接、便宜、可解释的靶点实验验证；再看疾病背景和已有文献。如果已经是老机制，就只作阳性对照；如果疾病解释链弱或同一药物反复命中许多弱相关靶点，就先暂缓。

生成时间：2026-06-05 09:19 UTC。长版数据 PDF 和 literature audit CSV 仍保留为证据备查。

专家阅读说明

亲和分

说明模型认为药物和蛋白可能相互作用。它是筛选信号，不代表真实 IC50，也不代表体内有效。

疾病证据

Open Targets、TxGNN 和 KG 说明靶点或药物是否和疾病方向有知识图谱关系。它能帮助解释，但不能替代实验。

CMap/CREEDS

看药物表达签名是否可能反转疾病签名。它是方向性线索，受细胞系、剂量和时间影响很大。

GTEX/HPA/DepMap

帮助判断靶点在哪些组织或疾病模型中表达，以及肿瘤中是否有依赖性。主要用于选模型。

DiffDock

看结构姿态是否可讨论。负数 confidence 不是坏事，也不是结合自由能；只能作为结构审阅辅助。

GPT 审阅

把上述证据合并成实际判断：先做哪个、哪些只作对照、哪些容易浪费实验预算。

建议首轮实验组合

50 个候选不建议一起做。首轮应由少量“正控/校准”证明实验体系有效，再选择能用低成本靶点实验判定真假的探索候选。下面清单是本次 GPT 复核后建议优先给专家讨论的组合。

用途	方向	候选	判断	第一步实验
首轮探索	免疫/炎症	Azelastine Hydrochloride RXFP1	免疫方向里较值得专家讨论，先做 RXFP1 功能实验和 H1 receptor counterscreen。	RXFP1 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
首轮探索	肿瘤	Alvimopan GCGR	可作为探索性候选，但先做低成本 GCGR 功能实验；不要直接进入肿瘤表型实验。	GCGR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
正控/校准	心血管	Dorzolamide Hydrochloride CA2	适合作为 enzyme assay 阳性对照。	CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。
正控/校准	心血管	Cyclosporine PPIA	适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。	PPIA/cyclophilin A 结合或酶活实验，并用 Cyclosporine 作阳性机制对照。
正控/校准	心血管	Gefitinib EGFR	作为阳性对照保留，不作为候选发现。	纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
正控/校准	免疫/炎症	Calcipotriene VDR	很适合作为免疫/炎症方向阳性对照。	VDR response element reporter、CYP24A1/经典 VDR 靶基因表达和配体竞争实验。
正控/校准	免疫/炎症	Cyclosporine PPIA	适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。	PPIA/cyclophilin A 结合或酶活实验，并用 Cyclosporine 作阳性机制对照。
正控/校准	免疫/炎症	Gefitinib EGFR	作为阳性对照保留，不作为候选发现。	纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
正控/校准	感染性疾病	Cyclosporine PPIA	适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。	PPIA/cyclophilin A 结合或酶活实验，并用 Cyclosporine 作阳性机制对照。
正控/校准	神经/精神	Atropine CHRM2	阳性对照。	CHRM2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

首轮解释。正控不是发现结果，而是证明 assay 和读数能工作；探索候选也不应直接进入复杂疾病模型，应先用 target engagement、功能 readout 和 counterscreen 判断是否值得继续。

候选总览

疾病方向分布: {"肿瘤": 10, "感染性疾病": 10, "心血管": 10, "神经/精神": 10, "免疫/炎症": 10}。GPT 审阅分类: {"阳性对照/校准": 20, "二线探索": 16, "暂缓/不建议首轮": 9, "机制延展/先排重": 3, "优先专家讨论": 2}。

#	方向	候选	GPT 分类	专家先看这一句	建议
1	肿瘤 Top 1	Afatinib Dimaleate EGFR	阳性对照/校准	这是 EGFR 肺癌药和 EGFR 靶点本身的召回，说明流程能找回强已知机制。	不作为新发现推进；保留一个 EGFR 阳性对照即可。
2	肿瘤 Top 2	Pazopanib Hydrochloride KIT	机制延展/先排重	这是多靶点 TKI 与 KIT 激酶的机制延展，肿瘤背景合理但已有较多公开线索。	可用于 kinase panel 校准或机制延展讨论，不宜包装为新靶点发现。
3	肿瘤 Top 3	Degarelix Acetate GNRHR	阳性对照/校准	这是前列腺癌激素轴的已知生物学，更多是疾病背景正控。	可作已知机制对照，不适合当新用途候选。
4	肿瘤 Top 4	Alvimopan GCGR	优先专家讨论	这是较新颖的组合：外周阿片拮抗剂指向胰高血糖素受体，直接文献少，但疾病机制较弱。	可作为探索性候选，但先做低成本 GCGR 功能实验；不要直接进入肿瘤表型实验。
5	肿瘤 Top 5	Palonosetron Hydrochloride HTR3A	阳性对照/校准	这是 5-HT3A 已知药理召回，适合做受体功能正控。	保留作 receptor assay 校准，不作为新发现。
6	肿瘤 Top 6	Dasatinib FRK	机制延展/先排重	Dasatinib 是广谱激酶药，FRK 属相邻激酶空间，解释性强但新颖性弱。	适合 kinase panel 或机制延展，不是首选新用途。
7	肿瘤 Top 7	Repotrectinib JAK1	二线探索	Repotrectinib 指向 JAK1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
8	肿瘤 Top 8	Quizartinib Dihydrochloride FLT3	阳性对照/校准	Quizartinib Dihydrochloride 指向 FLT3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
9	肿瘤 Top 9	Granisetron TSHR	二线探索	Granisetron 指向 TSHR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
10	肿瘤 Top 10	Fluoroestradiol F-18 ESR2	二线探索	Fluoroestradiol F-18 指向 ESR2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
11	感染性疾病 Top 1	Maraviroc NPY5R	暂缓/不建议首轮	HIV/CCR5 药物指向 NPY5R，感染病方向解释不直接，更像模型外推或 off-target 信号。	暂缓，不建议首轮采购。
12	感染性疾病 Top 2	Etonogestrel AR	暂缓/不建议首轮	激素类药物指向 AR，和感染病之间缺少直接机制桥接，更像疾病标签或宿主背景信号。	暂缓，不作为感染方向首轮候选；除非专家指定病毒-激素轴亚型。
13	感染性疾病 Top 3	Cobicistat FZD2	二线探索	HIV 药物增强剂指向 FZD2/Wnt 受体，是宿主通路调节假设；有新颖性，但感染病解释链需要补强。	建议列为二线探索；先做 FZD2/Wnt reporter 和 Cobicistat assay-interference 排查，再决定是否进入感染模型。
14	感染性疾病 Top 4	Darunavir And Cobicistat PTGER2	二线探索	抗 HIV 组合药指向 PTGER2，可能触及前列腺素-炎症轴，但组合制剂和宿主受体效应会强烈混杂。	二线保留；优先拆分 Darunavir 与 Cobicistat 单药验证 PTGER2 功能。
15	感染性疾病 Top 5	Naloxone Hydrochloride OPRK1	暂缓/不建议首轮	这是阿片受体药理空间的已知信号，但感染病方向解释不自然。	不作为感染方向首轮候选；如做只能作为受体 assay 对照。
16	感染性疾病 Top 6	Doxazosin Mesylate ADRA1A	暂缓/不建议首轮	这是 Doxazosin 的经典 alpha-1 受体药理，心血管解释强，但感染病解释弱。	不放入感染方向首轮；更适合作为心血管方向阳性对照。
17	感染性疾病 Top 7	Cyclosporine PPIA	阳性对照/校准	Cyclosporine-PPIA 是 cyclophilin 轴的经典机制，和病毒复制/宿主因子讨论有清楚入口。	适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。
18	感染性疾病 Top 8	Gefitinib EGFR	机制延展/先排重	EGFR 是上皮细胞信号和部分感染模型中可讨论的宿主通路，但 Gefitinib-EGFR 本身是已知强机制。	先做文献排重；若专家关心宿主 EGFR 依赖感染模型，可作机制延展对照。
19	感染性疾病 Top 9	Degarelix Acetate PTAFR	二线探索	PTAFR 与炎症和病原体-宿主相互作用有一定讨论空间，但 Degarelix 到 PTAFR 的药物-靶点证据较跳跃。	建议列为二线验证；先做 PTAFR 功能实验，再根据靶点证据决定是否做感染表型。
20	感染性疾病 Top 10	Octreotide Acetate SSTR2	暂缓/不建议首轮	Octreotide-SSTR2 是清楚的已知受体药理，但感染方向不是自然验证入口。	不作为感染方向首轮候选；可在内分泌/受体 assay 中作对照。
21					作阳性对照即可。

#	方向	候选	GPT 分类	专家先看这一句	建议
	心血管 Top 1	Doxazosin Mesylate ADRA1A	阳性对照/校准	这是 doxazosin 的经典 alpha-1 受体药理，心血管方向正控。	
22	心血管 Top 2	Octreotide Acetate SSTR2	阳性对照/校准	SSTR2 是 Octreotide 的经典受体，但心血管方向不是最自然的验证入口。	作为已知受体对照可保留，新发现价值低。
23	心血管 Top 3	Dorzolamide Hydrochloride CA2	阳性对照/校准	这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。	适合作为 enzyme assay 阳性对照。
24	心血管 Top 4	Donepezil Hydrochloride EDNRB	二线探索	Donepezil Hydrochloride 指向 EDNRB 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
25	心血管 Top 5	Propranolol Hydrochloride ADRA1D	二线探索	Propranolol Hydrochloride 指向 ADRA1D 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
26	心血管 Top 6	Metoprolol Succinate ADRB1	阳性对照/校准	Metoprolol Succinate 指向 ADRB1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
27	心血管 Top 7	Treprostinil Diolamine MC3R	二线探索	Treprostinil Diolamine 指向 MC3R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
28	心血管 Top 8	Latanoprost PTGER2	二线探索	Latanoprost 指向 PTGER2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
29	心血管 Top 9	Cyclosporine PPIA	阳性对照/校准	Cyclosporine-PPIA 是 cyclophilin 轴的经典机制，和病毒复制/宿主因子讨论有清楚入口。	适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。
30	心血管 Top 10	Gefitinib EGFR	阳性对照/校准	这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。	作为阳性对照保留，不作为候选发现。
31	神经/精神 Top 1	Naloxone Hydrochloride OPRK1	阳性对照/校准	这是阿片受体药理空间的已知召回，适合神经/精神方向受体 assay 校准。	阳性/机制对照。
32	神经/精神 Top 2	Atropine CHRM2	阳性对照/校准	这是 atropine 的经典抗胆碱能机制召回，适合作为 muscarinic assay 正控。	阳性对照。
33	神经/精神 Top 3	Naltrexone DRD3	暂缓/不建议首轮	Naltrexone 指向 DRD3 有神经相关性，但 opioid 主药理足以解释很多表型。	暂缓或二线。
34	神经/精神 Top 4	Revefenacin HTR1B	二线探索	Revefenacin 指向 HTR1B 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
35	神经/精神 Top 5	Naldemedine Tosylate DRD2	二线探索	Naldemedine Tosylate 指向 DRD2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
36	神经/精神 Top 6	Donepezil Hydrochloride HTR1A	暂缓/不建议首轮	Donepezil Hydrochloride 指向 HTR1A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	暂缓或忽略，不进入首轮。
37	神经/精神 Top 7	Oxymorphone Hydrochloride OPRM1	阳性对照/校准	Oxymorphone Hydrochloride 指向 OPRM1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
38	神经/精神 Top 8	Buprenorphine EDNRA	二线探索	Buprenorphine 指向 EDNRA 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
39	神经/精神 Top 9	Oxycodone Hydrochloride EDNRB	暂缓/不建议首轮	阿片药物指向 EDNRB，安全和主药理混杂都很强。	不建议首轮。
40	神经/精神 Top 10	Ioflupane I-123 CRHR1	二线探索	Ioflupane I-123 指向 CRHR1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
41	免疫/炎症 Top 1	Azelastine Hydrochloride RXFP1	优先专家讨论	Azelastine 是抗组胺药，RXFP1 属 relaxin 受体，炎症方向有组织重塑/免疫调节可讨论空间。	免疫方向里较值得专家讨论，先做 RXFP1 功能实验和 H1 receptor counterscreen。
42	免疫/炎症 Top 2	Olopatadine Hydrochloride DRD1	二线探索	抗组胺药指向 DRD1，实验可做但免疫方向解释间接。	二线探索，先做 receptor assay，不做复杂免疫模型。
43					很适合作为免疫/炎症方向阳性对照。

#	方向	候选	GPT 分类	专家先看这一句	建议
	免疫/炎症 Top 3	Calcipotriene VDR	阳性对照/校准	这是维生素 D 类药物与 VDR 的已知炎症/皮肤免疫机制，解释最清楚。	
44	免疫/炎症 Top 4	Oxycodone Hydrochloride EDNRB	暂缓/不建议首轮	阿片药物指向 EDNRB，安全和主药理混杂都很强。	不建议首轮。
45	免疫/炎症 Top 5	Naloxone Hydrochloride OPRK1	阳性对照/校准	这是阿片受体药理空间的已知召回，适合神经/精神方向受体 assay 校准。	阳性/机制对照。
46	免疫/炎症 Top 6	Doxazosin Mesylate ADRA1A	阳性对照/校准	这是 doxazosin 的经典 alpha-1 受体药理，心血管方向正控。	作阳性对照即可。
47	免疫/炎症 Top 7	Cyclosporine PPIA	阳性对照/校准	Cyclosporine-PPIA 是 cyclophilin 轴的经典机制，和病毒复制/宿主因子讨论有清楚入口。	适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。
48	免疫/炎症 Top 8	Gefitinib EGFR	阳性对照/校准	这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。	作为阳性对照保留，不作为候选发现。
49	免疫/炎症 Top 9	Degarelix Acetate PTAFR	二线探索	PTAFR 与炎症和病原体-宿主相互作用有一定讨论空间，但 Degarelix 到 PTAFR 的药物-靶点证据较跳跃。	建议列为二线验证；先做 PTAFR 功能实验，再根据靶点证据决定是否做感染表型。
50	免疫/炎症 Top 10	Octreotide Acetate SSTR2	阳性对照/校准	SSTR2 是 Octreotide 的经典受体，但心血管方向不是最自然的验证入口。	作为已知受体对照可保留，新发现价值低。

逐项 GPT 可行性复核

肿瘤 TOP 1

阳性对照/校准

Afatinib Dimaleate - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：这是 EGFR 肺癌药和 EGFR 靶点本身的召回，说明流程能找回强已知机制。

GPT 可行性判断：不作为新发现推进；保留一个 EGFR 阳性对照即可。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是可靠的。
为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 2,052, drug-target-disease 2,010, ClinicalTrials 药物-疾病方向 244。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Afatinib Dimaleate 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.987, affinity 0.965, DiffDock -0.45。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

肿瘤 TOP 2

机制延展/先排重

Pazopanib Hydrochloride - KIT

Mast/stem cell growth factor receptor Kit

专家先看这一句：这是多靶点 TKI 与 KIT 激酶的机制延展，肿瘤背景合理但已有较多公开线索。

GPT 可行性判断：可用于 kinase panel 校准或机制延展讨论，不宜包装为新靶点发现。

为什么可以考虑：机制上可解释，适合用来补充已知药理边界，但公开线索较多，发现价值有限。
为什么可能不值得做：如果人工确认已有直接机制验证，应降级为背景材料或忽略。

主要混杂因素：激酶药常有多靶点性质，需要 kinase panel 和通路 readout 区分真实靶点与相邻激酶抑制。

第一步实验：纯化 KIT kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 102, drug-target-disease 99, ClinicalTrials 药物-疾病方向 317。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Pazopanib Hydrochloride 是否能产生 KIT 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.965, affinity 0.927, DiffDock -4.42。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Degarelix Acetate - GNRHR

Gonadotropin-releasing hormone receptor

专家先看这一句：这是前列腺癌激素轴的已知生物学，更多是疾病背景正控。

GPT 可行性判断：可作已知机制对照，不适合当新用途候选。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：GNRHR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 25, drug-target-disease 20, ClinicalTrials 药物-疾病方向 156。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Degarelix Acetate 是否能产生 GNRHR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.939, affinity 0.966, DiffDock -4.58。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Alvimopan - GCGR

Glucagon receptor

专家先看这一句：这是较新颖的组合：外周阿片拮抗剂指向胰高血糖素受体，直接文献少，但疾病机制较弱。

GPT 可行性判断：可作为探索性候选，但先做低成本 GCGR 功能实验；不要直接进入肿瘤表型实验。

为什么可以考虑：新颖性较高，且靶点功能实验相对可执行；适合先用低成本实验判断是否有真实 target engagement。 **为什么可能不值得做：**不要直接做疾病细胞表型；如果靶点 readout 不成立，后续疾病实验没有解释力。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：GCGR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 12。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Alvimopan 是否能产生 GCGR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.938, affinity 0.955, DiffDock -2.31。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Palonosetron Hydrochloride - HTR3A

5-hydroxytryptamine receptor 3A

专家先看这一句：这是 5-HT3A 已知药理召回，适合做受体功能正控。

GPT 可行性判断：保留作 receptor assay 校准，不作为新发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：5-HT3A 电生理、膜电位或钙流 readout，区分拮抗、激动或变构调节。

Go/No-Go 门槛：必须看到受体依赖剂量反应和 subtype/counter-screen 特异性。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 3, drug-target-disease 2, ClinicalTrials 药物-疾病方向 103。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Palonosetron Hydrochloride 是否能产生 HTR3A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.927, affinity 0.929, DiffDock -1.46。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dasatinib - FRK

Tyrosine-protein kinase FRK

专家先看这一句：Dasatinib 是广谱激酶药，FRK 属相邻激酶空间，解释性强但新颖性弱。

GPT 可行性判断：适合 kinase panel 或机制延展，不是首选新用途。

为什么可以考虑：机制上可解释，适合用来补充已知药理边界，但 **为什么可能不值得做：**如果人工确认已有直接机制验证，应降级为公开线索较多，发现价值有限。背景材料或忽略。

主要混杂因素：激酶药常有多靶点性质，需要 kinase panel 和通路 readout 区分真实靶点与相邻激酶抑制。

第一步实验：纯化 FRK kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 6, drug-target-disease 5, ClinicalTrials 药物-疾病方向 403。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dasatinib 是否能产生 FRK 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.924, affinity 0.929, DiffDock -4.11。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Repotrectinib - JAK1

Tyrosine-protein kinase JAK1

专家先看这一句：Repotrectinib 指向 JAK1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 JAK1/Tyrosine-protein kinase JAK1 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Repotrectinib 是否能产生 JAK1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.900, affinity 0.882, DiffDock -1.01。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Quizartinib Dihydrochloride - FLT3

Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3

专家先看这一句：Quizartinib Dihydrochloride 指向 FLT3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：围绕 FLT3/Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Quizartinib Dihydrochloride 是否能产生 FLT3 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.887, affinity 0.961, DiffDock -5.21。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Granisetron - TSHR

Thyrotropin receptor

专家先看这一句：Granisetron 指向 TSHR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：TSHR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Granisetron 是否能产生 TSHR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.885, affinity 0.860, DiffDock -5.06。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Fluoroestradiol F-18 - ESR2

Estrogen receptor beta

专家先看这一句：Fluoroestradiol F-18 指向 ESR2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 ESR2/Estrogen receptor beta 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Fluoroestradiol F-18 是否能产生 ESR2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.883, affinity 0.935, DiffDock -2.57。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Maraviroc - NPY5R

Neuropeptide Y receptor type 5

专家先看这一句：HIV/CCR5 药物指向 NPY5R，感染病方向解释不直接，更像模型外推或 off-target 信号。

GPT 可行性判断：暂缓，不建议首轮采购。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。

为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：同一 Maraviroc 反复命中多个弱相关 GPCR/转运体，提示模型可能被药物-疾病背景和广义 off-target 性质放大。

第一步实验：NPY5R 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：风险/负向或安全上下文。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 14。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Maraviroc 是否能产生 NPY5R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.940, affinity 0.897, DiffDock -4.16。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Etonogestrel - AR

Androgen receptor

专家先看这一句：激素类药物指向 AR，和感染病之间缺少直接机制桥接，更像疾病标签或宿主背景信号。

GPT 可行性判断：暂缓，不作为感染方向首轮候选；除非专家指定病毒-激素轴亚型。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。

为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：激素轴和感染病之间需要明确亚型假设，否则很容易把内分泌背景误读成感染机制。

第一步实验：AR response element reporter、经典 AR 靶基因表达和配体竞争实验。

Go/No-Go 门槛：必须看到 AR 依赖的剂量反应；若不能和激素背景或毒性区分则停止。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Etonogestrel 是否能产生 AR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.876, affinity 0.808, DiffDock -2.01。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Cobicistat - FZD2

Frizzled-2

专家先看这一句：HIV 药物增强剂指向 FZD2/Wnt 受体，是宿主通路调节假设；有新颖性，但感染病解释链需要补强。

GPT 可行性判断：建议列为二线探索；先做 FZD2/Wnt reporter 和 Cobicistat assay-interference 排查，再决定是否进入感染模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：Cobicistat 是药代增强剂，CYP/转运体和 assay interference 风险高；组合制剂必须拆成单药验证。

第一步实验：FZD2/Wnt reporter 或 beta-catenin 通路 readout，确认药物是否调节 Wnt 信号。

Go/No-Go 门槛：必须出现 FZD2 依赖、方向一致的 Wnt readout；若只有 assay interference 则停止。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Cobicistat 是否能产生 FZD2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.869, affinity 0.798, DiffDock -4.46。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Darunavir And Cobicistat - PTGER2

Prostaglandin E2 receptor EP2 subtype

专家先看这一句：抗 HIV 组合药指向 PTGER2，可能触及前列腺素-炎症轴，但组合制剂和宿主受体效应会强烈混杂。

GPT 可行性判断：二线保留；优先拆分 Darunavir 与 Cobicistat 单药验证 PTGER2 功能。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：Cobicistat 是药代增强剂，CYP/转运体和 assay interference 风险高；组合制剂必须拆成单药验证。

第一步实验：PTGER2 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Darunavir And Cobicistat 是否能产生 PTGER2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.866, affinity 0.794, DiffDock -4.72。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Naloxone Hydrochloride - OPRK1

Kappa-type opioid receptor

专家先看这一句：这是阿片受体药理空间的已知信号，但感染病方向解释不自然。

GPT 可行性判断：不作为感染方向首轮候选；如做只能作为受体 assay 对照。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。

为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：OPRK1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Naloxone Hydrochloride 是否能产生 OPRK1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.850, affinity 0.981, DiffDock -1.59。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Doxazosin Mesylate - ADRA1A

Alpha-1A adrenergic receptor

专家先看这一句：这是 Doxazosin 的经典 alpha-1 受体药理，心血管解释强，但感染病解释弱。

GPT 可行性判断：不放入感染方向首轮；更适合作为心血管方向阳性对照。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。

为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：Doxazosin 的 alpha-1 主药理很强，任何心血管或 GPCR 表型都必须用 ADRA1A counterscreen 排除混杂。

第一步实验：ADRA1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Doxazosin Mesylate 是否能产生 ADRA1A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.845, affinity 0.974, DiffDock -3.51。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Cyclosporine - PPIA

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A

专家先看这一句：Cyclosporine-PPIA 是 cyclophilin 轴的经典机制，和病毒复制/宿主因子讨论有清楚入口。

GPT 可行性判断：适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：PPIA/cyclophilin A 结合或酶活实验，并用 Cyclosporine 作阳性机制对照。

Go/No-Go 门槛：需要 PPIA 依赖、非毒性窗口和感染模型 readout 同时成立；否则只作为机制正控。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Cyclosporine 是否能产生 PPIA 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.972, DiffDock -4.31。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Gefitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：EGFR 是上皮细胞信号和部分感染模型中可讨论的宿主通路，但 Gefitinib-EGFR 本身是已知强机制。

GPT 可行性判断：先做文献排重；若专家关心宿主 EGFR 依赖感染模型，可作机制延展对照。

为什么可以考虑：机制上可解释，适合用来补充已知药理边界，但 **为什么可能不值得做：**如果人工确认已有直接机制验证，应降级为公开线索较多，发现价值有限。背景材料或忽略。

主要混杂因素：激酶药常有多靶点性质，需要 kinase panel 和通路 readout 区分真实靶点与相邻激酶抑制。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Gefitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.971, DiffDock -0.96。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Degarelix Acetate - PTAFR

Platelet-activating factor receptor

专家先看这一句：PTAFR 与炎症和病原体-宿主相互作用有一定讨论空间，但 Degarelix 到 PTAFR 的药物-靶点证据较跳跃。

GPT 可行性判断：建议列为二线验证；先做 PTAFR 功能实验，再根据靶点证据决定是否做感染表型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：PTAFR 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Degarelix Acetate 是否能产生 PTAFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.841, affinity 0.969, DiffDock -3.52。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Octreotide Acetate - SSTR2

Somatostatin receptor type 2

专家先看这一句：Octreotide-SSTR2 是清楚的已知受体药理，但感染方向不是自然验证入口。

GPT 可行性判断：不作为感染方向首轮候选；可在内分泌/受体 assay 中作对照。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。 **为什么可能不值得做：**同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：Octreotide 的 SSTR 主药理和肽类药物暴露特征明显，非 SSTR 靶点需要非常直接的 target engagement 支持。

第一步实验：SSTR2 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Octreotide Acetate 是否能产生 SSTR2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.838, affinity 0.965, DiffDock -3.55。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Doxazosin Mesylate - ADRA1A

Alpha-1A adrenergic receptor

专家先看这一句：这是 doxazosin 的经典 alpha-1 受体药理，心血管方向正控。

GPT 可行性判断：作阳性对照即可。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：ADRA1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 10, drug-target-disease 6, ClinicalTrials 药物-疾病方向 39。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Doxazosin Mesylate 是否能产生 ADRA1A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.995, affinity 0.974, DiffDock -3.51。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Octreotide Acetate - SSTR2

Somatostatin receptor type 2

专家先看这一句：SSTR2 是 Octreotide 的经典受体，但心血管方向不是最自然的验证入口。

GPT 可行性判断：作为已知受体对照可保留，新发现价值低。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：SSTR2 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：风险/负向或安全上下文。PubMed drug-target 654, drug-target-disease 53, ClinicalTrials 药物-疾病方向 77。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Octreotide Acetate 是否能产生 SSTR2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.988, affinity 0.965, DiffDock -3.55。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

Carbonic anhydrase 2

专家先看这一句：这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。

GPT 可行性判断：适合作为 enzyme assay 阳性对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。

Go/No-Go 门槛：必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout；若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 47, drug-target-disease 12, ClinicalTrials 药物-疾病方向 83。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dorzolamide Hydrochloride 是否能产生 CA2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.980, affinity 0.953, DiffDock 0.51。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Donepezil Hydrochloride - EDNRB

Endothelin receptor type B

专家先看这一句：Donepezil Hydrochloride 指向 EDNRB 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：EDNRB 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Donepezil Hydrochloride 是否能产生 EDNRB 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.958, affinity 0.923, DiffDock -4.79。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Propranolol Hydrochloride - ADRA1D

Alpha-1D adrenergic receptor

专家先看这一句：Propranolol Hydrochloride 指向 ADRA1D 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 ADRA1D/Alpha-1D adrenergic receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Propranolol Hydrochloride 是否能产生 ADRA1D 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.923, affinity 0.874, DiffDock -5.24。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Metoprolol Succinate - ADRB1

Beta-1 adrenergic receptor

专家先看这一句：Metoprolol Succinate 指向 ADRB1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：围绕 ADRB1/Beta-1 adrenergic receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Metoprolol Succinate 是否能产生 ADRB1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.904, affinity 0.847, DiffDock -3.52。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Treprostinil Diolamine - MC3R

Melanocortin receptor 3

专家先看这一句：Treprostinil Diolamine 指向 MC3R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 MC3R/Melanocortin receptor 3 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Treprostinil Diolamine 是否能产生 MC3R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.860, affinity 0.785, DiffDock -2.15。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Latanoprost - PTGER2

Prostaglandin E2 receptor EP2 subtype

专家先看这一句：Latanoprost 指向 PTGER2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：PTGER2 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Latanoprost 是否能产生 PTGER2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.844, affinity 0.763, DiffDock -3.77。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Cyclosporine - PPIA

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A

专家先看这一句：Cyclosporine-PPIA 是 cyclophilin 轴的经典机制，和病毒复制/宿主因子讨论有清楚入口。

GPT 可行性判断：适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：PPIA/cyclophilin A 结合或酶活实验，并用 Cyclosporine 作阳性机制对照。

Go/No-Go 门槛：需要 PPIA 依赖、非毒性窗口和感染模型 readout 同时成立；否则只作为机制正控。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Cyclosporine 是否能产生 PPIA 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.972, DiffDock -4.31。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Gefitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。

GPT 可行性判断：作为阳性对照保留，不作为候选发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Gefitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.971, DiffDock -0.96。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Naloxone Hydrochloride - OPRK1

Kappa-type opioid receptor

专家先看这一句：这是阿片受体药理空间的已知召回，适合神经/精神方向受体 assay 校准。

GPT 可行性判断：阳性/机制对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：OPRK1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 638, drug-target-disease 133, ClinicalTrials 药物-疾病方向 317。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Naloxone Hydrochloride 是否能产生 OPRK1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 1.000, affinity 0.981, DiffDock -1.59。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Atropine - CHRM2

Muscarinic acetylcholine receptor M2

专家先看这一句：这是 atropine 的经典抗胆碱能机制召回，适合作为 muscarinic assay 正控。

GPT 可行性判断：阳性对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CHRM2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 94, drug-target-disease 13, ClinicalTrials 药物-疾病方向 156。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Atropine 是否能产生 CHRM2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.984, affinity 0.958, DiffDock -3.85。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Naltrexone - DRD3

D(3) dopamine receptor

专家先看这一句：Naltrexone 指向 DRD3 有神经相关性，但 opioid 主药理足以解释很多表型。

GPT 可行性判断：暂缓或二线。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。

为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：DRD3 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：风险/负向或安全上下文。PubMed drug-target 5，drug-target-disease 4，ClinicalTrials 药物-疾病方向 237。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Naltrexone 是否能产生 DRD3 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.967，affinity 0.936，DiffDock -2.12。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Revefenacin - HTR1B

5-hydroxytryptamine receptor 1B

专家先看这一句：Revefenacin 指向 HTR1B 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：HTR1B 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -，drug-target-disease -，ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Revefenacin 是否能产生 HTR1B 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.955，affinity 0.919，DiffDock -1.91。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Naldemedine Tosylate - DRD2

D(2) dopamine receptor

专家先看这一句：Naldemedine Tosylate 指向 DRD2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：DRD2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -，drug-target-disease -，ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Naldemedine Tosylate 是否能产生 DRD2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.946，affinity 0.906，DiffDock -2.98。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Donepezil Hydrochloride - HTR1A

5-hydroxytryptamine receptor 1A

专家先看这一句：Donepezil Hydrochloride 指向 HTR1A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：暂缓或忽略，不进入首轮。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。
为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：HTR1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Donepezil Hydrochloride 是否能产生 HTR1A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.937, affinity 0.925, DiffDock -1.75。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Oxymorphone Hydrochloride - OPRM1

Mu-type opioid receptor

专家先看这一句：Oxymorphone Hydrochloride 指向 OPRM1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。
为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：OPRM1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Oxymorphone Hydrochloride 是否能产生 OPRM1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.936, affinity 0.892, DiffDock 0.66。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Buprenorphine - EDNRA

Endothelin-1 receptor

专家先看这一句：Buprenorphine 指向 EDNRA 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。
为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：EDNRA 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Buprenorphine 是否能产生 EDNRA 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.932, affinity 0.886, DiffDock -5.71。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Oxycodone Hydrochloride - EDNRB

Endothelin receptor type B

专家先看这一句：阿片药物指向 EDNRB，安全和主药理混杂都很强。

GPT 可行性判断：不建议首轮。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。

为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：EDNRB 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Oxycodone Hydrochloride 是否能产生 EDNRB 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.930, affinity 0.883, DiffDock -5.20。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Ioflupane I-123 - CRHR1

Corticotropin-releasing factor receptor 1

专家先看这一句：Ioflupane I-123 指向 CRHR1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 CRHR1/Corticotropin-releasing factor receptor 1 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Ioflupane I-123 是否能产生 CRHR1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.928, affinity 0.880, DiffDock -2.89。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Azelastine Hydrochloride - RXFP1

Relaxin receptor 1

专家先看这一句：Azelastine 是抗组胺药，RXFP1 属 relaxin 受体，炎症方向有组织重塑/免疫调节可讨论空间。

GPT 可行性判断：免疫方向里较值得专家讨论，先做 RXFP1 功能实验和 H1 receptor counterscreen。

为什么可以考虑：新颖性较高，且靶点功能实验相对可执行；适合先用低成本实验判断是否有真实 target engagement。

为什么可能不值得做：不要直接做疾病细胞表型；如果靶点 readout 不成立，后续疾病实验没有解释力。

主要混杂因素：抗组胺主药理和 GPCR off-target 容易混在一起，需要 H1 receptor 与同家族受体 counterscreen。

第一步实验：RXFP1 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Azelastine Hydrochloride 是否能产生 RXFP1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.960, affinity 0.925, DiffDock -4.20。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Olopatadine Hydrochloride - DRD1

D(1A) dopamine receptor

专家先看这一句：抗组胺药指向 DRD1，实验可做但免疫方向解释间接。

GPT 可行性判断：二线探索，先做 receptor assay，不做复杂免疫模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：抗组胺主药理和 GPCR off-target 容易混在一起，需要 H1 receptor 与同家族受体 counterscreen。

第一步实验：DRD1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0，drug-target-disease 0，ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Olopatadine Hydrochloride 是否能产生 DRD1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.920，affinity 0.869，DiffDock -4.41。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Calcipotriene - VDR

Vitamin D3 receptor

专家先看这一句：这是维生素 D 类药物与 VDR 的已知炎症/皮肤免疫机制，解释最清楚。

GPT 可行性判断：很适合作为免疫/炎症方向阳性对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：VDR response element reporter、CYP24A1/经典 VDR 靶基因表达和配体竞争实验。

Go/No-Go 门槛：需要靶点依赖转录 readout 与疾病相关表型同向；若只有广泛分化或毒性效应则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 63，drug-target-disease 1，ClinicalTrials 药物-疾病方向 2。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Calcipotriene 是否能产生 VDR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.918，affinity 0.867，DiffDock -4.36。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Oxycodone Hydrochloride - EDNRB

Endothelin receptor type B

专家先看这一句：阿片类药物指向 EDNRB，安全和主药理混杂都很强。

GPT 可行性判断：不建议首轮。

为什么可以考虑：疾病解释链较弱、主药理混杂或安全/负向上下文较强，投入后很容易得到难解释结果。

为什么可能不值得做：同一药物反复命中多个弱相关靶点时，通常提示广义 polypharmacology 或模型泛化，不适合先做。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：EDNRB 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：风险/负向或安全上下文。PubMed drug-target 0，drug-target-disease 0，ClinicalTrials 药物-疾病方向 360。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Oxycodone Hydrochloride 是否能产生 EDNRB 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.907，affinity 0.883，DiffDock -5.20。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Naloxone Hydrochloride - OPRK1

Kappa-type opioid receptor

专家先看这一句：这是阿片受体药理空间的已知召回，适合神经/精神方向受体 assay 校准。

GPT 可行性判断：阳性/机制对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：OPRK1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Naloxone Hydrochloride 是否能产生 OPRK1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.850，affinity 0.981，DiffDock -1.59。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Doxazosin Mesylate - ADRA1A

Alpha-1A adrenergic receptor

专家先看这一句：这是 doxazosin 的经典 alpha-1 受体药理，心血管方向正控。

GPT 可行性判断：作阳性对照即可。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：ADRA1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Doxazosin Mesylate 是否能产生 ADRA1A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.845，affinity 0.974，DiffDock -3.51。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Cyclosporine - PPIA

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A

专家先看这一句：Cyclosporine-PPIA 是 cyclophilin 轴的经典机制，和病毒复制/宿主因子讨论有清楚入口。

GPT 可行性判断：适合作为感染方向机制正控或流程校准，不包装为新发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：PPIA/cyclophilin A 结合或酶活实验，并用 Cyclosporine 作阳性机制对照。

Go/No-Go 门槛：需要 PPIA 依赖、非毒性窗口和感染模型 readout 同时成立；否则只作为机制正控。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Cyclosporine 是否能产生 PPIA 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843，affinity 0.972，DiffDock -4.31。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Gefitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。

GPT 可行性判断：作为阳性对照保留，不作为候选发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Gefitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.971, DiffDock -0.96。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Degarelix Acetate - PTAFR

Platelet-activating factor receptor

专家先看这一句：PTAFR 与炎症和病原体-宿主相互作用有一定讨论空间，但 Degarelix 到 PTAFR 的药物-靶点证据较跳跃。

GPT 可行性判断：建议列为二线验证；先做 PTAFR 功能实验，再根据靶点证据决定是否做感染表型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：PTAFR 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Degarelix Acetate 是否能产生 PTAFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.841, affinity 0.969, DiffDock -3.52。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Octreotide Acetate - SSTR2

Somatostatin receptor type 2

专家先看这一句：SSTR2 是 Octreotide 的经典受体，但心血管方向不是最自然的验证入口。

GPT 可行性判断：作为已知受体对照可保留，新发现价值低。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：SSTR2 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：待人工排重/缓存缺失。PubMed drug-target -, drug-target-disease -, ClinicalTrials 药物-疾病方向 -。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Octreotide Acetate 是否能产生 SSTR2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.838, affinity 0.965, DiffDock -3.55。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。